

Psicocirugía en un paciente con trastorno obsesivo compulsivo resistente

Óscar Meneses Luna^a, Francisco Javier Valencia Granados^a, Manuel Hernandez Salazar^b y Ángel Mauricio Soriano^a

^aServicio de Psiquiatría. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. ISSSTE. México DF. México.

^bCoordinación de Servicio Modulares. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. ISSSTE. México DF. México.

El término psicocirugía fue introducido por primera vez por Egaz Moniz en 1937 para los procedimientos ablativos o resectivos del lóbulo frontal para disminuir síntomas psiquiátricos. La psicocirugía es un tratamiento disponible actualmente en varios centros mundiales, como tratamiento definitivo en pacientes bien seleccionados para enfermedades como el trastorno obsesivo-compulsivo resistente (TOC-R) y la agresividad resistente (AR) al tratamiento. En México no existen comités multidisciplinarios para el tratamiento de estas enfermedades psiquiátricas, ya que este tipo de pacientes tiene períodos de estancias hospitalarias prolongados e incapacidad laboral y personal, ésta es una alternativa no convencional que ha brindado la oportunidad de reincorporar a este tipo de pacientes y llevar una mejor observancia del tratamiento, se sabe que los centros más destacados en este ámbito están en Inglaterra, Estados Unidos y Chile.

El presente artículo es un reporte de un caso en el que se demuestra la efectividad del procedimiento para disminuir los síntomas obsesivo y compulsivo resistentes, y al mismo tiempo corroborar que las funciones mentales superiores no están afectadas.

Palabras clave:

Trastorno obsesivo compulsivo resistente. Psicocirugía. Agresividad resistente.

Psychosurgery in a patient with refractory obsessive-compulsive disorder

The term psychosurgery was first used by Egaz Moniz in 1937 to describe ablative or resective procedures in the frontal lobe to reduce psychiatric symptoms. Psychosurgery is currently available in various centers throughout the world as the definitive treatment in selected patients with disorders such as refractory obsessive-compulsive syndrome and refractory aggression.

In Mexico, multidisciplinary committees for the treatment of these psychiatric disorders are lacking since this type of patient undergoes long periods of hospitalization, as well as occupational and personal disability. Psychosurgery is an unconventional alternative that offers the possibility of reintegrating this type of patient and of achieving greater treatment compliance. The most important centers for psychosurgery are found in England, the USA and Chile.

The present article reports a case that demonstrates the effectiveness of psychosurgery in reducing refractory obsessive-compulsive symptoms and corroborates that higher mental functions are left intact.

Key words:

Refractory obsessive-compulsive disorder. Psychosurgery. Refractory aggression.

ANTECEDENTES

Los tratamientos neuroquirúrgicos para los trastornos psiquiátricos tienen una larga y controversial historia^{1,2}. Desde el uso de trepanaciones en Europa Central, Amé-

rica del Sur y América Central (Monte Alban) posiblemente para liberar los demonios del espíritu³. A partir del uso de la lobotomía hasta la actualidad el abordaje de los procesos psiquiátricos se ha modificado notablemente⁴. En la actualidad mediante instrumentos esterotácticos es posible guiar con exactitud milimétrica las lesiones que se generan. La psicocirugía ha gozado del apoyo entusiasta, así como ha experimentado desprecio⁵. En 1908, Horsley y Clark introducen el método estereotáctico en animales de experimentación, es en 1947 cuando

Correspondencia: Dr. A.M. Soriano Pérez.
Servicio de Psiquiatría. CMN 20 de Noviembre.
Avda. Félix Cuevas 540. 03100 México DF. México.
Correo electrónico: med_angelsor@yahoo.com.mx

TABLA 1. Psicofarmacos empleados en el paciente

Benzodiacepina	No benzodiacepínico	Antidepresivo tricíclico	Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina	Neuroléptico típico	Neuroléptico atípico	Anticomicial	Anticolinérgico
Clonazepam, diazepam	Buspirona	Anafranil	Sertralina, fluoxetina, paroxetina	Haldol, Melleril, Trilafon, Piportil	Clozapina, Risperdal	Carbamazepina	Trihexifenidilo, Biperiden

Spiegel y Wycis inician su aplicación en el ser humano con intervenciones en el tálamo en pacientes psicópatas⁶. Desde entonces empieza la era del desarrollo de esta técnica, inicialmente en Alemania y Francia, luego en otros países del mundo. En 1935, después de que Jacobsen y Fulton en la Universidad de Yale realizaran la ablación del lóbulo frontal en monos con efectos calmantes, Egaz Moniz y Almeida Lima, en Portugal, extrajeron materia blanca del lóbulo frontal en 20 pacientes psicóticos, con buenos resultados de los síntomas indeseados⁶. En 1936, Freeman y James, en la Universidad de Washington, introdujeron la técnica psicoquirúrgica de la lobotomía prefrontal en los Estados Unidos.

A finales de la década de los cuarenta la psicocirugía se practicaba en todo el mundo, se operaba a 5.000 pacientes cada año. En Chile, Poblete, luego de perfeccionarse en esta especialidad en Alemania, crea en 1962 el Servicio de Neurocirugía Estereotáctica en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, debido a la gran demanda de pacientes y las grandes ventajas que presentaba dicha técnica⁶. Actualmente, con la neurocirugía estereotáctica las posibilidades de éxito son mayores, los riesgos y efectos secundarios son mínimos por la precisión del método⁷. Hoy en día, la psicocirugía es un tratamiento considerado de invasión mínima, selectivo y diseñado para casos bien seleccionados, como: síntomas psiquiátricos resistentes a tratamientos convencionales. Por ejemplo, agresividad extrema, obsesiones o compulsiones, depresión y ansiedad incapacitantes y resistentes^{3,4}. Recientes avances en la tecnología y procedimientos neuroanatómicos funcionales repercuten directamente en una corta estancia hospitalaria, disminuyen el coste y el tiempo para pacientes crónicos y brindan una oportunidad para que la psicocirugía llegue a ser una opción más del tratamiento de los síntomas de algunas enfermedades psiquiátricas¹. La neurocirugía estereotáctica es una técnica que utiliza aparatos de precisión e instrumentos muy perfeccionados que permiten la localización y el abordaje de cualquier estructura intracraneana, basándose en cálculos mediante imágenes muy exactas⁶. La estereotaxis (del griego, “guiar en el espacio”) consiste en la ubicación exacta de un punto intracraneano mediante un aparato de precisión que, instalado externamente en la cabeza del

paciente, permite dimensionar espacialmente las diferentes estructuras cerebrales. Una de las indicaciones de la psicocirugía es el trastorno obsesivo compulsivo resistente (TOC-R)^{6,7}.

Trastorno obsesivo compulsivo resistente

Selección del paciente

La dirección que determinó las condiciones requeridas para la intervención quirúrgica del TOC especificaba que el paciente debía: *a)* cumplir los criterios del DSM-IV para TOC; *b)* presentar síntomas graves de TOC junto con discapacidad funcional, y *c)* no haber recibido tratamientos farmacológicos y de psicoterapia. Se solicitó que el psiquiatra tratante lo propusiera para dicho procedimiento. El comité de evaluación, formado por psiquiatras, neurocirujanos, neurólogos, electrofisiólogos y un abogado, revisó la historia médica del paciente y determinó si se aprobaba la propuesta de recurrir a la intervención quirúrgica y posterior dictamen de comité de ética. A continuación el psiquiatra, el neurocirujano, el neurólogo y el electrofisiólogo entrevistaron y examinaron directamente al paciente en la consulta externa, siempre que el estado del paciente lo permitiera. Posteriormente, se evaluó al paciente con instrumentos estandarizados como la escala obsesiva-compulsiva de Yale-Brown, test de Barcelona, WAIS, MMPI. El candidato número uno a la intervención quirúrgica, varón de 27 años de edad, presentaba un TOC que no había respondido a ninguno de los tratamientos psicofarmacológicos disponibles en tiempo y dosis establecidos ni tampoco a la psicoterapia. En el paciente debía haberse efectuado previamente diversas tentativas terapéuticas adecuadas (como mínimo 10 semanas con la dosis máxima tolerada) con, al menos, 3 inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (clomipramina, fluoxetina, sertralina, paroxetina o citalopram) y a su vez en sinergia con 2 de los siguientes fármacos: litio, clonazepam, buspirona o un neuroléptico. El paciente recibió una terapia conductual de al menos 20 h y otros tratamientos (tabla 1). La información relacionada al cumplimiento terapéutico del paciente se obtuvo del psiquiatra derivante, de la

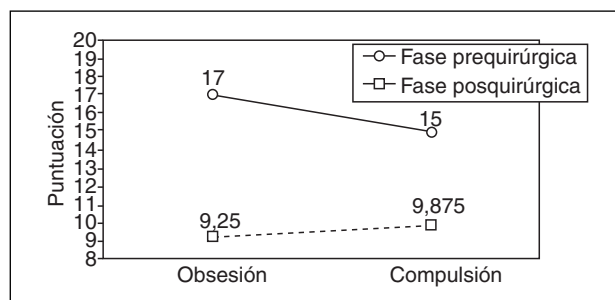


Figura 1. Escala de Yale-Brown. Interacción entre fase y síntoma.

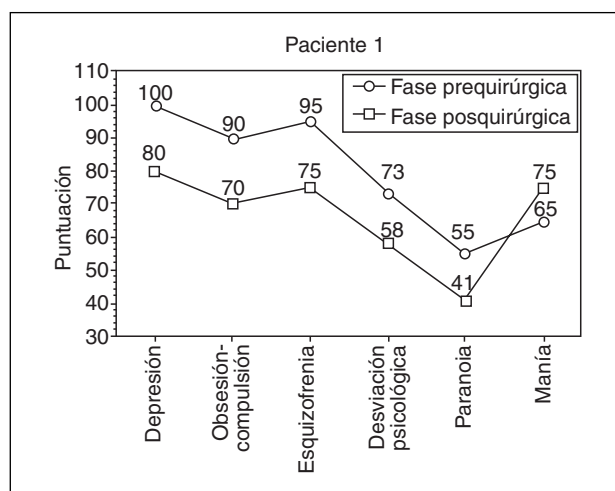


Figura 2. Escala MMPI.

historia médica y de los datos aportados por los familiares del paciente. Por el médico que refirió se trató de obtener la mayor parte de la información de que los intentos terapéuticos no fueron satisfactorios para la mejoría de los síntomas del TOC. Posteriormente aceptado el paciente para cingulotomía, se obtuvo el consentimiento informado para la intervención quirúrgica y para el seguimiento clínico.

Antecedentes personales no patológicos

Características del paciente

El paciente presentaba dificultades en la concentración, sensación de estar flotando, dificultades para realizar su aseo personal, por lo que tenía que recibir asistencia, debido a que pasaba mucho tiempo con rituales consistentes en repasar mentalmente ideas e imágenes (obsesivo-compulsivas), en esos estados permanecía hasta 12 h; en ocasiones se mantenía en la misma posición, en forma "casi" catatónica, y se orinaba y defecaba en la ropa; mantenía fija su atención en los objetos y en las personas, con su atención principalmente hacia los geni-

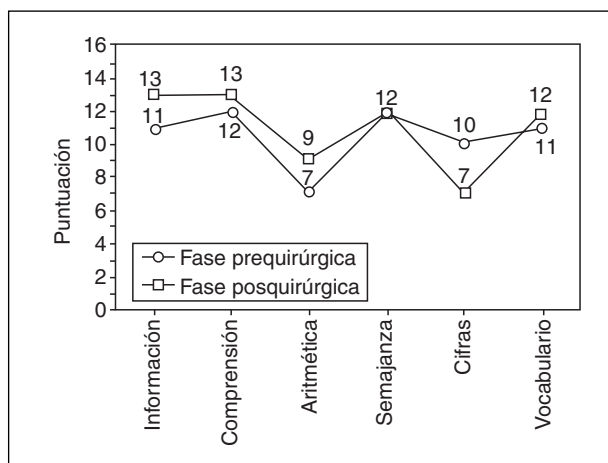


Figura 3. Escala de inteligencia verbal.

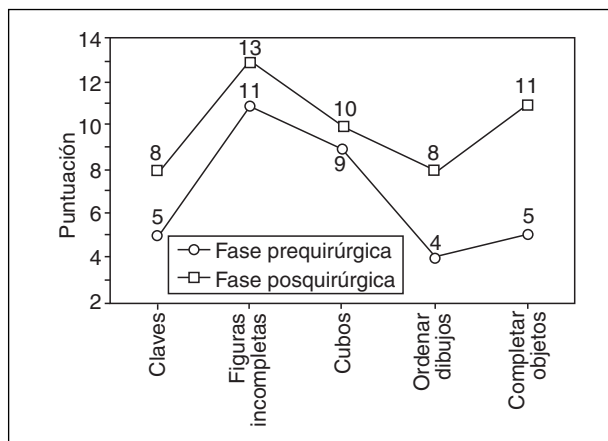


Figura 4. Escala de inteligencia ejecutiva.

tales de las mujeres, mentalmente repetía las palabras, las imágenes de cosas que observaba o escuchaba, sin lograr controlarlas.

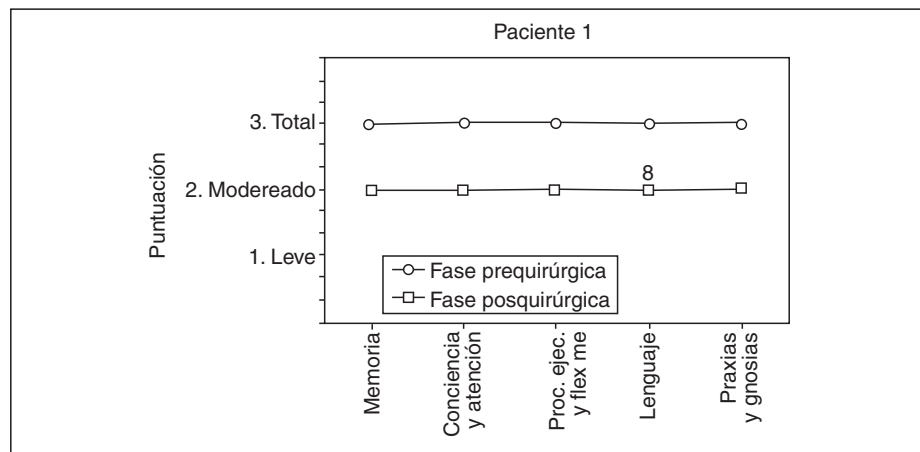
Examen mental prequirúrgico

En el examen se observó cara de tristeza con postura tensa, su voz es forzada, habla lentamente, con tono normal, afecto hipotímico, niega alteraciones sensorio-perceptivas y no impresiona tenerlas, su pensamiento es lento, lógico, coherente, comprensible, contenido de preocupación en relación con su enfermedad, sin ideas suicidas, con proyección a futuro, con discalculia, orientado globalmente, juicio dentro de la realidad, con conciencia de enfermedad mental, psicomotricidad extremadamente lenta, con movimientos finos de extremidades superiores.

Técnica quirúrgica

El blanco elegido fue el cíngulo bilateral, debido a las potenciales complicaciones visuales y motoras referidas en los años noventa sobre otros blancos como las capsu-

Figura 5. Escala neuropsicológica. Interacción entre fase y módulo.



lotomías; se sometió a termocingulotomía estereotáctica bilateral guiada por estereotaxis con equipo Leibinger Fisher (Alemania) en programa Estereoplan plus y verificado en STP guiado con TC-RM para el volumen lesional y ventriculografía para la correcta colocación de electrodos TCB 0133 en dos familias de lesiones escalonadas en 5 puntos con 3 mm de distancia a 70 °C durante 60 s cada lesión. El procedimiento resultó sin incidentes con un tiempo de hospitalización postoperatorio de 2 días.

Evaluaciones de seguimiento

A los 2, 6, 12, 24, 36, 48, 60 y 72 meses, se evaluó al paciente mediante entrevista clínica, clinimetría, estudios psicológicos y neuropsicológicos que se muestran en las figuras 1-5, para posteriormente realizar un análisis descriptivo.

RESULTADOS

Examen mental posquirúrgico

El paciente se encuentra consciente, orientado, cooperador en el interrogatorio, contesta en forma fluida y espontánea, tarde menos en repetir o revisar los elementos, como las palabras que escucha o las personas que ve; su talante es aparentemente eutímico y con buena modulación, conserva juicio de la realidad. Es importante señalar que en el período posquirúrgico terminó la preparatoria. A 6 años de la cirugía, el paciente realiza actividades de forma aceptable en comparación con la incapacidad previa a la cirugía realizada.

En la tabla 2 se muestran los puntajes obtenidos de la Escala de Yale-Brown para obsesividad y compulsividad (EYB-OC) de las evaluaciones prequirúrgica y posquirúrgica, donde se observa predominio de la obsesión so-

TABLA 2. Resultados del paciente en la escala Yale-Brown

Fase	Obsesión	Compulsión	Puntuación	Calificación
Prequirúrgica	17	15	32	Grave extremo
Posquirúrgica	12	12	24	Grave moderado
Posquirúrgica	12	10	22	Moderado
Posquirúrgica	12	13	25	Grave extremo
Posquirúrgica	10	12	22	Moderado
Posquirúrgica	9	15	24	Grave moderado
Posquirúrgica	7	7	14	Leve
Posquirúrgica	6	6	12	Leve
Posquirúrgica	6	4	10	Leve

Puntuación: subclínico, 0-9; leve, 10-15; moderado, 16-22; grave moderado, 23-24; grave extremo, 25 o más.

bre la compulsión. El puntaje total prequirúrgico es de 32, que corresponde a un estado grave extremo.

En la figura 1 se observa claramente una disminución significativa en la fase posquirúrgica en la EYB-OC con una diferencia de 7,75 en la obsesividad y de 5,13 en la compulsividad. En el posquirúrgico se obtiene una puntuación promedio de 19, que corresponde a un estado moderado.

En la figura 2 se muestra el estudio psicológico de personalidad (Minnesota breve) en donde el dato de mayor interés por las características de psicopatología del paciente es la reducción en la puntuación de la escala de obsesividad-compulsividad (PT), y lleva, por lo tanto, a una disminución de la mayoría de las escalas y permite mejor adaptabilidad al medio.

En la figura 3 se muestra el estudio psicológico de inteligencia verbal. La escala verbal mide la retención de la información adquirida con anterioridad. Se observa que se recupera en la mayoría de los subtest y presenta una disminución en el subtest de dígitos que puede co-

responder a una pérdida temporal de la memoria inmediata.

En la figura 4 se muestra el estudio psicológico de inteligencia ejecutiva. En esta escala estamos midiendo la capacidad visuoespacial y motora que nos ayuda a resolver tareas. Se observa que hay mejoría en todos los subtest.

En la figura 5 se presenta la escala neuropsicológica, debido a que se utilizan mediciones conductuales, éstas nos son de utilidad para valorar las habilidades y capacidades que se relacionan con el funcionamiento cerebral. La puntuación de 3 corresponde a una alteración total que se observa en todos los subtest en el prequirúrgico. En el posquirúrgico persiste la alteración en un grado moderado.

En términos generales concluimos que la evolución posquirúrgica en este paciente fue adecuada, ya que le permitió incorporarse de una forma funcional al núcleo familiar y desempeñar trabajos sencillos, como de albañilería y computación, y terminar su preparatoria. En algunos momentos ha presentado recaídas, sin llegar a la gravedad prequirúrgica, ya que no observa buen cumplimiento del tratamiento farmacológico, incluso se puede pensar en probable segundo tiempo quirúrgico.

DISCUSIÓN

Lo más sobresaliente es la mejoría del síntoma obsesivo compulsivo en la escala de referencia (Yale-Brown para TOC) con una diferencia en el síntoma obsesivo de 7,75, y en el síntoma de compulsión, de 5,13, lo que se ve reflejado clínicamente en el desenvolvimiento del paciente. En el test de Minnesota los ítems que nos interesan por los síntomas del paciente son la escala de depresión, obsesivo-compulsivo y esquizofrenia (DPTE), que se encuentran con una puntuación menor después de la cirugía lo que indica cambios favorables. Observamos que al disminuir los síntomas depresivos su actividad se ve aumentada, y se refleja en un incremento en la puntuación de la escala de manía. En cuanto a la prueba de inteligencia, en las subescalas verbal y ejecutiva tenemos resultados favorables. En la escala neuropsicológica se observa un deterioro menor en todos los ítems.

CONCLUSIONES

Podemos observar que los procedimientos psiquiátricos no convencionales, como la psicocirugía, son un re-

curso de gran utilidad que puede brindar solución a pacientes con síntomas psiquiátricos invalidantes y de difícil control por los medios más conocidos, como la psicoterapia, los recursos psicofarmacológicos y la terapia electroconvulsiva.

Para comprobar que el procedimiento psicoquirúrgico aplicado en este caso fue el más indicado, se emplearon escalas clínicas psiquiátricas, neuropsicológicas y psicológicas con adecuada validez y confiabilidad, con lo cual se sustentó la incapacidad en la que se encontraba el paciente antes de la cirugía, y posteriormente demostrar su eficacia, así como mejoría en su calidad de vida.

El objetivo de la psicocirugía fue lograr disminuir la sintomatología obsesiva y compulsiva y demostrar que no existe deterioro de las funciones cognitivas. De esta forma se logró una mejor adaptación del paciente a la dinámica familiar, mejor control farmacológico e independencia.

Una de las ventajas fundamentales de este procedimiento es que no hay deterioro de las funciones cognitivas, como se observó en los primeros años que se realizaba este procedimiento psicoquirúrgico, dadas las condiciones en los avances tecnológicos y en el blanco quirúrgico, resultado de un mayor conocimiento de las neurociencias.

Finalmente, es necesario hacer una revisión de los condicionantes y mitos que se tienen sobre la psicocirugía para impedir que las ideas preconcebidas y dogmáticas no sean un obstáculo para el desarrollo de alternativas de esta índole, que poseen mayores alcances en comparación con los procedimientos convencionales, que se ofrecen a pacientes cuando han sido agotadas las alternativas tradicionales; por último, se hace hincapié en que el elemento fundamental para un excelente resultado es la selección del paciente apropiado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Feldman RP, Goodrich JT. Psychosurgery: a historical overview. *Neurosurgery*. 2001;48:647-57.
2. Bermans J, Iskandar MD, et al. History of Functional Neurosurgery. *Neurosurgery Clinics of North America*. 1995;(1).
3. Meyerson BA. Neurosurgical treatment of mental disorders: Introduction and indications; chapter 202; p. 1955-63; *Textbook of Stereotactic and Functional Neurosurgery*; Edit. Interamericana.
4. Bertolin G, et al. La psicocirugía estereotáctica: vigencia actual. España.
5. Iskandar BJ, et al. History of Functional Neurosurgery. *Neurosurgery Clinics of North America*. 1995;6(1).
6. Manccinni R. Neurocirugía estereotáctica en Chile. *Rev Psiquiátrica*. 1984;255-7.
7. Kaplan-Sadok. Sinopsis de Psiquiatría. 8ª. ed. Edit. Panamericana. p. 1280-1.